西醫基層醫療服務審查執行會高屏區分會

110 年高屏區大內科、皮膚科、精神科、老人科審查專家諮詢會議紀錄

會議時間：110 年 12 月 17 日(星期五)中午 12 時 30 分

會議地點：視訊會議

主席：楊組長宜璋

出席人員：大內科、皮膚科、精神科、老人科審查醫師

列席人員：江主任委員俊逸、賴聰宏理事長、王宏育理事長、張維仁理事長、林誓揚組長、鄭英傑組長、中央健康保險署高屏業務組費用二科、費用三科、黃雅惠、陳幸慧

紀錄：陳幸慧

壹、 主席致詞

貳、 報告事項

一、高屏區以往的審查共識，在沒有重新修改前，全部適用，如果有新的共識與規定，舊版自然失效。

二、重申醫療法第 67 條與醫事檢驗師法第 14 條規定，及配合事項：

【醫療法第 67 條】

1. 醫療機構應建立清晰、詳實、完整之病歷。

2. 前項所稱病歷，應包括下列各款之資料：

(1) 醫師依醫師法執行業務所製作之病歷。

(2) 各項檢查、檢驗報告資料。

(3) 其他各類醫事人員執行業務所製作之紀錄。

3. 醫院對於病歷，應製作各項索引及統計分析，以利研究及查考。

【醫事檢驗師法第 14 條】

1. 醫事檢驗師檢驗，應製作檢驗結果紀錄，出具檢驗報告，並於檢驗報告上簽名或蓋章。

2. 醫事檢驗師對於醫師所開之檢驗單，以檢驗一次為限；檢驗後，醫事檢驗師應於檢驗單上簽名或蓋章，並添註檢驗日期。

綜上，為了解醫療院所提供醫療照護之適切性、合理性及必要性。

結論：建議由分會發文至各四縣市醫師公會向院所宣導以下事項：

(一)規定醫療院所送審應檢送完整之病歷者，若為檢驗檢查報告送審時，應包含檢驗機構代號、名稱及醫事檢驗師姓名。不接受診所自行製表(或手寫紀錄)之檢驗報告。

(二)院所申報的藥品、檢驗或處置，需符合開立條件或起始治療的病歷與正式檢驗報告或影印本，院所送審時務必備齊相關資料佐證(例如：降血脂藥物、降血糖藥物、病毒性肝炎、降尿酸藥物、心電圖、超音波、內視鏡...等等)。

(三)基層診所依據醫院下轉的處方接續所開立的藥物與檢驗，抽審時務必檢送相關資料佐證，如原醫院的病歷摘要影本、處方籤或藥袋影本、雲端藥歷影本、轉診單影本、健康存摺影本...等等任何能證明的資料。並需注意檢驗檢查追蹤時程與處方時效，六個月內可依醫院下轉的處方申報。六個月後必須依照西醫基層相關規定申報。

三、為求審查公平性與一致性，請審查醫師執行審查業務時必須依據健保相關支付標準、藥品給付規定、審查注意事項與本分會的審查醫師研討會共識， 以避免「該核刪而未核刪」或「不該核刪卻核刪」的情形。同時核刪理由應該避免下列文字：「非必要之用藥」、「過度申報，X 月 X 日已申報過」、「病歷潦草雜亂過於簡略」、「使用的劑量不對」、「不

符合審查共識」、「第一次開立不宜這麼多天」，更應避免核刪理由用詰問句，如「不知懷疑是哪一種腸胃疾病？」。這些都見於遭爭議審議撤銷的案件。

四、110 年第 2 季爭議審議案件統計，西醫基層總額醫療爭審案件撤銷率全區 4%，台北 2%，北區 5%，中區 3%，南區 7%、高屏 9%，東區 3%，高屏撤銷率仍最高，後續配合事項：

(一)自 110 年 8 月起本區已針對撤銷案件全面回鍋醫審，請初審及複審醫師檢視是否同意撤銷理由?若同意，且無審查共識疑義者，請勿再以相同理由核減、若有審查共識疑義者，必要時召開高屏區審查共識會議。若不同意撤銷理由，請初審、複審醫師詳述不同意之論點(例如:明顯違反規定被撤銷)，將由審查組提全執會討論並向爭審會反映。

(二)彙整 110 年第一季撤銷案例，以下提供四件案件，經初審、複審醫師回饋案例分享，1 案同意撤銷、3 案不服爭審會撤銷理由，案例說明如下：

1. 案例一：診所開立 NSAID 予洗腎患者，爭審會撤銷。

初審、複審醫師→同意撤銷理由。

2. 案例二：高血壓患者驗 Na 離子（09021C，40 點）遭核刪，費用年月 109/10（同性質案例三例），爭審會撤銷。

【初審】0524A 非必要之檢查或檢驗

【複審】歉難補付，理由為：109/08 才驗過，由所附之資料，無需如此頻繁檢驗。

【撤銷理由】查所附資料，健保署初、複核意見不予支付理由代碼「0524A」、「109 年 8 月才驗過，無需如此頻繁驗」，依系爭病人診斷為「本態性(原發性)高血壓」，院所爭審檢驗~鈉(09021C)，

申請理由為：「長期使用藥物控制血壓患者應定期追蹤 serumelectrolyte...評估藥物可能造成的電解質失衡」，依病情記載：「Hypertension has been with this subject for 20+ years with now daily ordinary blood pressure levels of 120/60 mmHg; now with regular treatment amlodipine」。符合病情所需。

初審、複審醫師不服撤銷，理由→病歷中並未明載有高血鈉或低血鈉的懷疑症狀，且 109/08 才驗過正常，腎功能亦正常，仍認為檢驗 NA 過於頻繁，應予核刪。

3. 案例三:病人診斷為「廣泛性焦慮症」申報低密度脂蛋白-膽固醇 09044C（250 點），爭審會撤銷。

【初審】0524A 非必要之檢查或檢驗。

【複審】TC and TG normal。

【撤銷理由】查所附資料，健保署初、複核意見為不予支付理由代碼「0524A」、「TC and TG normal」，系爭病人診斷為「廣泛性焦慮症」，就系爭項目「低密度脂蛋白-膽固醇(09044C)」部分，依病情記載：「palpitation of heart developed very often in this month. Occasionally chest tightness also developed meanwhile」，施行系爭檢驗項目，符合病情所需。

初審、複審醫師不服撤銷，理由→無其他三高危險因子，該院診斷為"焦慮症"，TG & Total-Cholesterol 正常實無需檢驗 LDL-Cholesterol，事實也證明 LDL-Cholestero 在正常範圍。

4. 案例四：某聯合診所掛不同科開立安眠藥遭核刪診察費 00109C（385 點），爭審會撤銷。

【初審】非特殊疾患請歸同一醫師看診。

【複審】就病歷的描述，確實不須另掛一科在心臟專科就診。

【申請理由】病人於108年12月2日就診神經內科主訴失眠，用藥為quetiapine與zopiclone，有肝臟功能異常病史。失眠用藥處方並非常見，也非心臟專科醫師、新陳代謝專科醫師常開立的處方，且當日針對上述用藥評估是否有產生錐體外路徑症狀的副作用與肝功能異常可能產生的神經學症狀，分析失眠原因與衛教，以上皆需要神經專科醫師評估。

【撤銷理由】查卷附資料，系爭項目為「一般門診診察費(00109C)」，健保署初、複核意見為「非特殊疾患請歸同一醫師看診」、「就病歷的描述，確實不須另掛一科在心臟專科就診」。申請理由：如上，依「特約醫事服務機構門診醫療服務點數及醫令清單」顯示，病人109年9月7日分別於申請人診所心臟內科及神經科(系爭)就診，查心臟內科病歷無失眠相關診斷及病情記載，復依神經科病歷紀錄，病人診斷為「失眠」，依病情記載：「Stilnox ADR floating sensation while walking ，ok with Xanax.....usingXanax all improved.」，由神經科醫師評估病情並處方Xanax藥物治療，核符病情所需。

初審醫師不服撤銷，理由→依病歷所描述之症狀，此患者僅開一顆抗焦慮劑就加掛一個科別，且此實在有違健保推動整合醫療的精神。況且此患者在9月7日當天在同一診所就已經讓3位醫師看診，個人認為，簡單的藥物一般內科即可開立，不需多掛一科門診，若以此為常態，爭審又同意此行為，恐形成醫療浪費。

複審醫師不服撤銷，理由→

一、失眠用藥並非心內、新陳代謝科常開立的處方，以此理由加掛神經內科開立一顆XANAX，真的很奇怪。

二、爭審醫師認定類此「符合病情」就給處方，是否形同糖尿病患感冒，看完新陳代謝科就加掛耳鼻喉科，違背健保署推動整合門診之意。個人認為，若只有一次，下次回診就由心臟科開立此藥，若每次都這樣就診，而以爭審通過為由恐形成醫療浪費。

結論：有關爭議審議案例將提供給所有審查醫藥專家分享，高屏分區審查醫藥專家若針對爭議審議案件，若仍有不同意見，將由高屏分會提案至全執委會進一步討論。

五、有關院所於爭議審議時仍補正相關資料，致爭審撤銷率偏高一案。

說明：110 年 11 月 17 日全執會審查專家諮詢會議，針對院所於爭議審議時仍可補正相關資料一事，會中做出結論：院所與初審送核時，應善盡「提供完整病歷或診療相關證明文件」之責任與義務，不應經常性於申復或爭議審議時，補正前階段未附資料，造成前後審查結果差異。為彰顯審查公正合理，提醒審查醫藥專家，院所提供初審資料未盡完整時，得要求院所補正，院所未補正遭核減而提請申覆時，不需再通知院所提供與初審相同之補正資料。另外，申覆時所附資料，應為審查最終資料，爭議審議應僅就申覆資料進行書面審查。（此結論已於 11 月 28 日全執會確認）**建議審查醫藥專家及健保署後續配合事項如下：**

(一)初核核減案件：請初核審查醫師於重要依據文件加蓋「原始病歷章」，院所提供初審資料未盡完整時，得要求院所補正。

(二)核定前請費用科協助檢視是否加蓋「原始病歷章」?若遺漏請補蓋。

六、重申消化性潰瘍用藥使用規定

1.4 元以下之 peptic ulcer 用藥包括 H2 blocker、PPI 不需胃鏡報告，

即可使用（健保藥品給付規定）。

2.因腦中風，冠狀動脈疾病或周邊血管疾病，或易出血體質(備註) 而需使用雙重抗血小板藥物及抗凝血藥物，如 aspirin、 warfarin、 tirofiban、 cilostazol、 P2Y12 inhibitor (如 clopidogrel、 ticagrelor、ticlopidine、 prasugrel)或新一代口服抗凝血藥物(如 rivaroxaban、 apixaban、edoxaban、 dabigatran)病人得以使用每日藥費 6.5 元以下之氫離子幫浦阻 斷劑(PPI)，最長以 16 週為限; 若為曾接受過內視鏡檢查，經彩色內視鏡圖譜證實有活動性消化性潰瘍或上消化道出血，最長以一年為限，如使用期間或停藥後，活動性消化性潰瘍再發或上消化道出血，得再治療一年。

備註:易出血性體質建議如下:

I. 第五期慢性腎臟病（eGFR<15mL/min/1.73M2)或透析治治療中

II. 血小板<80,000 /mm3。

III. 肝臟疾病且 INR>1.7。

IV. 其他凝血功能不全疾病。

3.需使用 NSAIDs 而曾經上消化道內視鏡或 X 光攝影證實有過潰瘍，得於使用 NSAIDs 期間內，使用消化性潰瘍用藥。

七、重申 103 年大內科審查醫師研討會有關 COPD 病患用藥審查規定結論：

1. 現階段 COPD 的診斷明顯是低估，COPD 的用藥也沒有濫用的情形，COPD 病人在診所所得到的醫療照護受影響。

2.診斷 COPD 前，應考量發病時間及以 IgE 或 Eosinophil count 排除 asthma。以肺部 X 片排除肺部腫瘤、heart failure、 TB 及 bronchioectasis。

3.考量診所設備，病歷如記載完整病患病況，治療評估病患衛教資料及或 FEV1/FVC，也可依 COPD 嚴重度開予處方治療。

4.申報 COPD 用藥時，病歷應記載詳細，並應檢附肺部 X 光片報告（視發病時間可雲端二年內之記錄）以及 mMRC & CAT 問卷。

八、重申甲促素結合體抗體 (12121C)審查注意事項：

1.Graves’ disease 之診斷，須 TSH、T3/T4(或 free form)任一項異常。

2.Graves’ disease 之追蹤，每半年得檢驗一次 12121C。

3.以下特別狀況得依臨床需求與專業判斷，不受半年一次之限制。

(1)用於判斷 Graves’ disease 是否可以停藥，宜具有以下三條件:甲亢藥一天一顆、TSH、T3/T4（或 free form)正常、甲狀腺超音波正常。

(2)孕婦(包括有 Graves’ disease 病史或確診者)。

(3)有明顯之甲狀腺眼病變。

九、重申糖尿病用藥規定

(一)第二線糖尿病用藥:TZD 製劑、DPP-4 inhibitor、SGLT-2 inhibitor 此三類藥物限用於已接受 Metformin 使用劑量達 1000 mg/day 三個月以上，且 HbA1C 仍大於等於 7 之第二型糖尿病病人。對 Metformin 有使用禁忌或不能耐受者，不在此限。(105.8.26 共識)

(二)SGLT2 inhibitor +DPP-4 inhibitor 複方：

1.每日限處方 1 粒。

2.限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin，且併用 SGLT2 inhibitor 或 DPP4 inhibitor 治療至少 6 個月，糖化血色素值(HbA1c)仍高於 7.5%者。

(三)GLP-1 RA：

1.限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物，且併用下列藥品之一持續 6 個月之後，HbA1c 仍高於 8.5%以上之第二型糖尿病患者:(1)SGLT-2 抑制劑、(2)DPP-4 抑制劑、(3)SGLT-2 抑制劑合併 DPP-4 抑制劑複方藥品、(4)Insulin

2.當患者已接受前述口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。

3.發生重大心血管事件，如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術(revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之病人，於接受過最大耐受劑量的 metformin 後，仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者，可考慮不須使用其他口服降血糖藥品而考慮使用 liraglutide 或 dulaglutide 或 semaglutide。

4.本藥品不得與 DPP-4 抑制劑、SGLT-2 抑制劑併用。

5.109 年 5 月 1 日前已依生效前之給付規定使用本類藥物之病人，得繼續使用原藥物至醫師更新其處方內容。

(四)GLP-1 RA + insulin 之複方製劑(如 Soliqua)

1.限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物，且併用下列藥品之一持續 6 個月之後，HbA1c 仍高於 8.0%以上之第二型糖尿病成人病人:(1)SGLT-2 抑制劑、(2)DPP-4 抑制劑、(3)SGLT-2 抑制劑合併 DPP-4 抑制劑複方藥品、(4)Insulin(每日劑量少於 60 單位)

2.本品不得與 DPP-4 抑制劑、SGLT-2 抑制劑併用。

十、重申高屏區精神科審查共識會議結論：（108.5.3）

(一)為維護醫療品質，精神科專業處置及心理治療(如 45087C，特殊心理

治療，成人)之審查原則：

1. 根據精神科審查注意事項(一) &(四)

(一)精神科專業審查案件，醫療院所應檢送其醫事人員之基本資料及精神醫療人力統計表，供審核參考。

(四)心理治療審查原則:門診部分:審查時考量醫療人力、專業訓練及病情需要，並將心理治療內容摘述記載於病歷。

2. 審查醫師審查時應參酌院所專業精神醫療人力、時間及病情需要， 評估申報該醫令之合理性。

(二)重申精神科審查注意事項（五）

申報各項精神醫療治療費診療項目之案件送審時，須檢附就診當次及前後看診或治療紀錄。45022C、45034C、45070C、 45016C 及 45010C 得採用定型化單張，並須有欄位做文字附加充分個別化的補充說明。不符者，不予支付。（各項診療項目紀錄內容請詳參審查注意事項。）

十一、發現有多家基層診所以「歐姆龍非侵入性血管檢測儀（衛部醫器輸宇第 018150 號）測量 ABI（Ankle Brachial Index）卻申報 18008C（杜卜勒氏血流測定，週邊血管，150 點），依據多位審查專家意見確認申報錯誤，**建議分會及高屏業務組合作輔導院所自清繳回。**

十二、全執會 8 月 22 日通過建議增定 109 年開放表別腺病毒抗原檢查(14064C)不予支付指標，函請健保署納入研議：

院所開立腺病毒抗原檢查醫令總量之限制如下:

西醫基層院所每月申報腺病毒抗原檢查醫令總量不得超過 25 件(依據 109 年 7 月至 110 年 6 月西醫基層院所每月申報 97 百分位平均值訂定)。

不予支付點數=[(西醫基層院所申報腺病毒抗原檢查(醫令代碼為14064C)醫令總量-25)/西醫基層院所申報腺病毒抗原檢查醫令總量]x西醫基層院所腺病毒抗原檢查總申報點數。

十三、全執會 11 月 28 日通過健保署函詢西醫基層總額不予支付指標修訂案：「初次使用 ticlopidine 或 clopidogrel 前未使用 aspirin 比率」檔案分析審查不予支付指標排除條件：分子排除急性心肌梗塞、消化性潰瘍、缺血性腦中風案件，比照醫院總額修訂。

參、 臨時動議

提案：有關西醫基層醫療費用內科審查注意事項-降血脂藥物審查原則增訂原因乙節。

說明：關於藥品給付規定降血脂類藥品之相關規定，於 102 年已有異動，並且刪除「如已達治療目的得考慮減量至最低有效劑量」等內容。重申應避免該類已刪除給付規定，卻持續沿用舊制核扣費用之情形，再請各審查醫藥專家多加注意。

結論：符合藥品給付規定，處方降血脂藥物達標後，是否維持原劑量或減輕劑量，應尊重臨床醫師意見。